

Pasuruan, 15 April 2024

Nomor : 544/RSPHS/E-PM/DIR/IV/2024
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Permohonan Benchmarking Data

Kepada Yth.
dr. Nur Mazidah
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang
Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya kebutuhan kelengkapan data akreditasi di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo khususnya dalam bab PMKP, maka bersama dengan ini kami mengajukan untuk dilakukannya Benchmarking Data Capaian Data Mutu Nasional dari pihak RS Prima Husada Malang. Data yang kami peroleh hanya dapat diakses oleh Tim PMKP sehingga Kerahasiaan data dapat dipertanggungjawabkan, penyimpanan data dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun, selebihnya akan dilakukan pemusnahan data (dihapus).

Adapun terkait informasi dan komunikasi dapat menghubungi Lidia Puspita Kencana, S.K.M. (085235384897)

Demikian surat permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Sukorejo,



dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS.

Tembusan :

Tim PMKP RS Prima Husada Malang

Lampiran
Surat Permohonan Benchmarking data
Nomor :

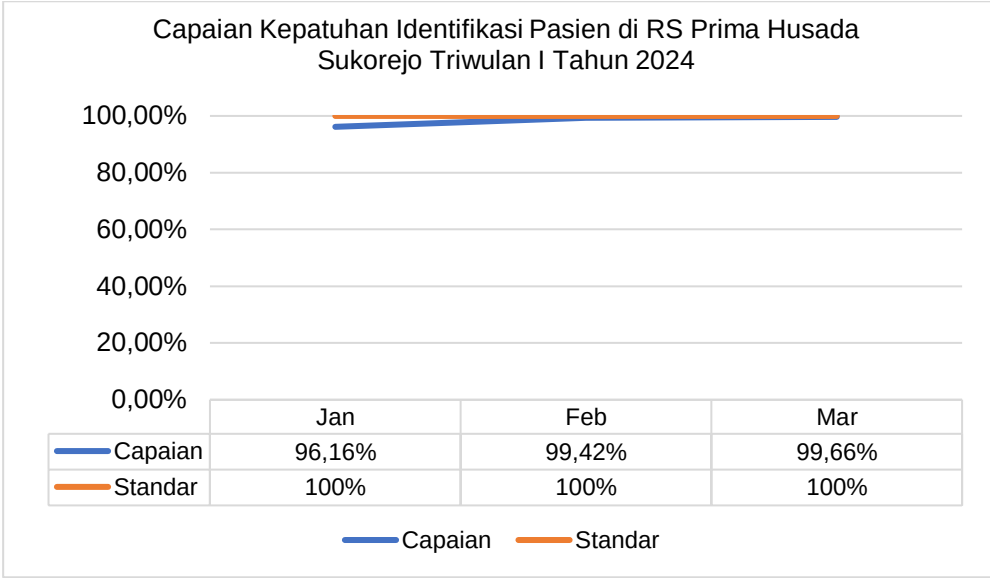
Berikut merupakan penjelasan mengenai capaian indikator mutu nasional RS. Prima Husada Sukorejo pada bulan januari sampai maret 2024.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Mutu Nasional RSPH Sukorejo Triwulan I Tahun 2024

No	Judul Indikator	Std	Bulan			Rata-rata	Ket
			Jan	Feb	Mar		
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	96,16 %	99,42%	99,66%	98,41%	Tidak Tercapai
2	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea emergency ≤ 30 menit	≥80%	92,86 %	100%	93,33%	95,40%	Tercapai
3	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	≥80%	61,60 %	49,52 %	53,64%	54,92%	Tidak Tercapai
4	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	≤5%	2,17%	0,97%	0%	1,05%	Tercapai
5	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	≥80%	73,96 %	73,15 %	79,48%	75,53%	Tidak Tercapai
6	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
7	Kepatuhan Penggunaan For-mularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
8	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥85%	75,36 %	73,57 %	73,20%	74,04%	Tidak Tercapai
9	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	100%	92,43 %	94,%	97,11%	94,55%	Tidak Tercapai
10	Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway	≥80%	88%	90%	63%	80,33%	Tercapai
11	Kepuasan Pasien Dan Keluarga	≥76.61 %	82,26 %	75,61 %	61.11%	72,99%	Tidak Tercapai
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥80%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
13	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	91,78 %	95,56 %	93,68%	93,67%	Tidak Tercapai

3.1.2 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional yang Tidak Diinginkan

1. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Tabel 3.2 Analisis Capaian Indikator Nasional yang Tidak Di Inginkan pada Triwulan I Tahun 2024

Standar	Judul Indikator	Standar	Capaian Bulan			Rata-rata	Area
			Jan	Feb	Mar		
Nasional	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	96,16%	99,42 %	99,66 %	98,41 %	All rawat inap, farmasi, radiologi, laboratorium, rawat jalan, rehab medis, kamar operasi, ICU

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di RS. Prima Husada Sukorejo pada bulan Maret Tahun 2024 mencapai 98,41%. Dari 5250 pasien yang diobservasi pada 14 unit ditemukan 5232 pasien yang dilakukan tindakan identifikasi pasien secara tepat dan 18 pasien tidak dilakukan identifikasi dengan tepat. Berikut merupakan rata-rata capaian untuk setiap unit:

- a. IGD

: 100%
- b. Instalasi Rawat Jalan

: 100%
- c. Instalasi Rawat Inap 2A

: 80%, dari 110 pasien yang di observasi ditemukan 12 pasien yang tidak dilakukan identifikasi pasien dengan benar, 6 pasien tidak dilakukan secara visual (tidak melihat gelang identitas pasien) hanya lisan saja dan 6 pasien tidak dilakukan identifikasi secara lisan hanya visual saja.
- d. Instalasi Rawat Inap 2B

: 100%
- e. Instalasi Rawat Inap 3A

: 100%
- f. Instalasi Rawat Inap 3B

: 100%
- g. Instalasi Kamar Operasi

: 100%
- h. ICU

: 100%
- i. Ponak

: 100%
- j. Maternitas

: 96,13%, dari 155 pasien yang di observasi ditemukan 6 pasien yang tidak dilakukan identifikasi pasien dengan benar, yaitu tidak diidentifikasi secara visual (melihat gelang identitas pasien) tetapi dilakukan secara lisan saja
- k. Neonatologi

: 100%



I. Laboratorium	: 100%
m. Radiologi	: 100%
n. Rehab Medik	: 100%

Tabel 3.3 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada triwulan 1 Tahun 2024 adalah 98,41% dan belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Rencana : Merubah kebiasaan individu agar selalu patuh terhadap identifikasi pasien Harapan : Petugas yang namanya masuk dalam kategori tidak patuh dapat dilakukan pemantauan kepatuhan saat identifikasi ke pasien. Tindakan : a. Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien b. Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh c. Koordinasi dengan kabid keperawatan dan SDM terkait nama-nama staff yang tidak patuh d. Menghimbau dan mengingatkan ke semua staff di unit pelayanan mengenai pentingnya melakukan identifikasi pasien untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi kepada pasien
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Cara mengidentifikasi petugas kepada pasien dengan menggunakan 2 identitas dari 4 identitas yang ditentukan (nama, tgl lahir, nomor RM dan gelang identitas) 2. Ketepatan waktu dilakukan identifikasi pasien (pemberian produk darah, obat, tindakan, pemeriksaan penunjang, diet)
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian triwulan I yakni 98,41% dapat disimpulkan bahwa kepatuhan identifikasi pasien belum mencapai standar 100%. Ini dikarenakan masih ditemukan: a. 18 petugas tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien dengan rincian : 1) 0,23% (12 petugas) yang tidak melakukan identifikasi secara visual 2) 0,11% (6 petugas) yang tidak melakukan identifikasi secara lisan 3) 0,27% (14 petugas) yang tidak melakukan identifikasi saat pemberian pengobatan 4) 0,19% (10 petugas) yang tidak melakukan identifikasi saat melakukan prosedur Tindakan 5) 0,11% (6 petugas) yang tidak melakukan identifikasi saat melakukan prosedur diagnostik b. Adapun nama petugas yang tidak patuh dalam identifikasi pasien antara lain: 1) Nanda Diah Fibrianti, S.Kep., Ns (4 kali) 2) Novita Febri Setiyani, S.Kep., Ns (3 kali) 3) Sri Rahayu Kurniawati., S.Kep Ns (1 kali) 4) Antika Setya Narutama, S.Kep., Ns (1 kali) 5) Nanda Daeng Pamungkas, A.Md.Kep (1 kali) 6) Intania Cahya Andini, A.Md.Kep (1 kali) 7) Rodeyah A.Md.Kep (1 kali) 8) Yulia Noer Rohmah, S.Tr., Keb (2 kali) 9) Intan Nur Rohmawati, A.Md.Keb (2 kali) 10) Iga Octanesya Iksahadi A.Md Keb (1 kali) 11) Nurul Komariyah, Amd. Keb (1 kali)
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Maret tahun 2024



	mencapai 98,41%, masih ditemukan beberapa petugas di unit IRNA 2A dan Maternitas yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Koordinasi dengan kepala unit untuk melakukan pemanggilan staff yang tercatat tidak patuh melakukan identifikasi pasien 2. Koordinasi dengan Kabid Keperawatan dan SDM terkait staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien 3. Memberikan catatan khusus tentang ketidakpatuhan staff dan diarsipkan dalam berkas SDM. 4. Karu mencatat juga dalam Form Evaluasi Kinerja yang terbaru terkait nama-nama staf yang tidak patuh dan direkap semesteran dan form tersebut harus di tandatangani oleh staf yang bersangkutan 5. Rapat Mutu dengan karu 6. Pemantauan rapat unit di notulen tercatat membahas mutu 7. Karu memberikan proses pembelajaran yang mendidik 8. Evaluasi pencapaian pada Bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin.
--	--

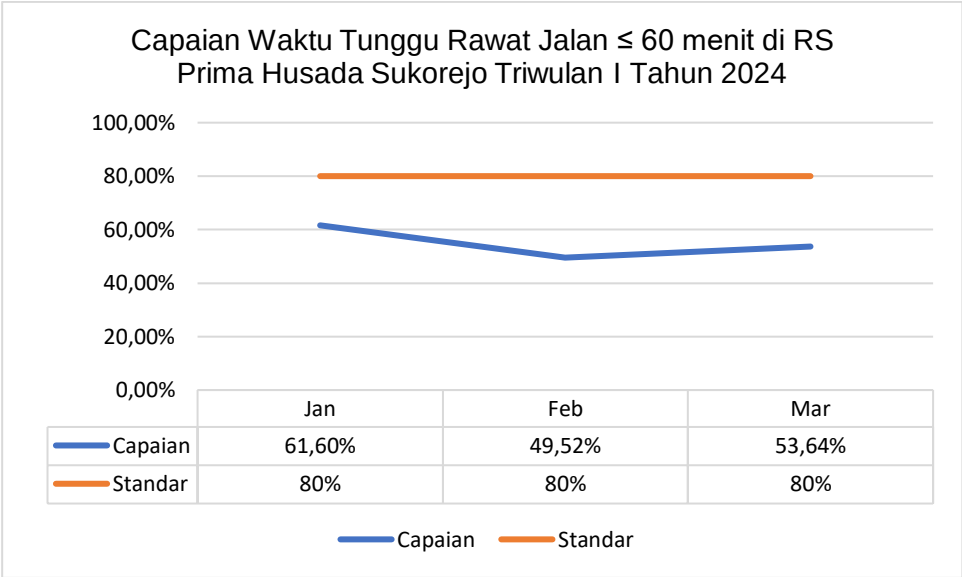
Tabel 3.4 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan kepala unit untuk melakukan pemanggilan staff yang tercatat tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Merubah kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi pasien dengan benar	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Rapat – koordinasi dan monitoring kepatuhan staff setelah peneguran	Kepala Ruangan	Satu bulan
2	Koordinasi dengan Kabid Keperawatan dan SDM terkait staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien	Merubah kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi pasien dengan benar	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Rapat – koordinasi dan monitoring kepatuhan staff setelah peneguran	Ka. Ruangan, Tim SKP, Kabid Keperawatan, SDM dan Mutu	Satu bulan
3	Memberikan catatan khusus tentang ketidakpatuhan staff dan diarsipkan dalam berkas SDM.	Merubah kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi pasien dengan benar	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Catatan Khusus staff yang tidak patuh	SDM	Satu bulan
4	Karu mencatat juga dalam Form Evaluasi Kinerja yang terbaru terkait nama-nama staf	Merubah kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi pasien	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Pencatatan staff yang tidak patuh dalam form evaluasi kinerja yang terbaru	Kepala Ruangan Unit Masing-Masing	Satu bulan



	yang tidak patuh dan direkap semesteran dan form tersebut harus di tandatangani staf yang bersangkutan	dengan benar				
5	Rapat Mutu dengan Kepala Ruangan	Melakukan evaluasi terhadap kinerja system manajemen mutu	Kepala ruangan	Rapat Komite Mutu & Kepala Ruangan	Rapat Komite Mutu & Kepala Ruangan	Satu bulan 1 kali
6	Pemantauan rapat unit di notulen tercatat membahas mutu	Mutu Unit dapat terkontrol secara berkelanjutan dan masalah terkait mutu dapat segera di tindaklanjuti	Seluruh staff di Unit	Rapat Bulanan Unit	Rapat Bulanan di setiap Unit	Satu bulan
7	Karu memberikan proses pembelajaran yang mendidik	Staff yang bertugas paham terkait pembelajaran yang disampaikan	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Sosialisasi yang dilakukan oleh kepala ruang kepada timnya terkait pembelajaran	Kepala Ruangan	Satu bulan
8	Evaluasi pencapaian pada Bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin.	Kepala Ruang dapat mengetahui setiap petugas unit yang patuh terhadap identifikasi pasien	Seluruh staff di Unit	Supervisi yang dilakukan oleh kepala ruang dan mencatat staff yang tidak patuh dalam form evaluasi kinerja yang terbaru	Kepala Ruangan	Satu bulan

2. Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit



Tabel 3.5 Analisis Capaian Indikator Nasional yang Tidak Di Inginkan pada Triwulan I Tahun 2024

Standar	Judul Indikator	Standar	Capaian Bulan			Rata-rata	Area
			Jan	Feb	Mar		
Nasional	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 Menit	≥80%	61,60%	49,52 %	53,64 %	54,92 %	All rawat inap, farmasi, radiologi, laboratorium, rawat jalan, rehab medis, kamar operasi, ICU

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, waktu tunggu rawat jalan mengalami peningkatan pada bulan Maret 2024 yakni 53,64% dibandingkan dengan bulan Februari 2024 yakni 49,52% tetapi capaian yang paling tinggi yaitu pada bulan Januari 61,6%. Adapun rata-rata waktu tunggu rawat jalan di RS Prima Husada Sukorejo sampai bulan Maret Tahun 2024 mencapai 54,92%. Di Bulan Maret 2024, dari 110 kedatangan pasien yang di observasi ditemukan 49 pasien yang harus menunggu lebih dari 60 menit yaitu dengan rata-rata 102 menit (1 jam 42 menit). Berikut merupakan jumlah pasien yang menunggu lebih dari 60 menit sampai dilayani oleh dokter diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.6. Jumlah Pasien yang menunggu lebih dari 60 menit sampai dilayani oleh dokter pada Triwulan I Tahun 2024.

No	Nama Dokter Poli	Jumlah Pasien yang menunggu > 60 menit
1	dr. Aan Dwi Prasetyo, Sp.N	2
2	dr. Andika Widiанти, Sp.K.J	4
3	dr. Arianto Prabowo, Sp. OT	3
4	dr. Nyoman Indra Bayu, Sp.M	5
5	dr. Dimas Aryo Pamungkas, Sp.PD	2
6	dr. Dio Mafazi Fabrianta, Sp.U	6
7	dr. Maria Valentina Evelyn, Sp. JP	1



8	dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp.N	9
9	dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp.U	4
10	dr. Fiski Purantoro, Sp.OT	8
11	dr. Heriyatmo, Sp. PD	2
12	dr. I Gede Made Oka Rahaditya, Sp.OT.	3

Tabel 3.7 PDSA Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit pada Triwulan 1 Tahun 2024

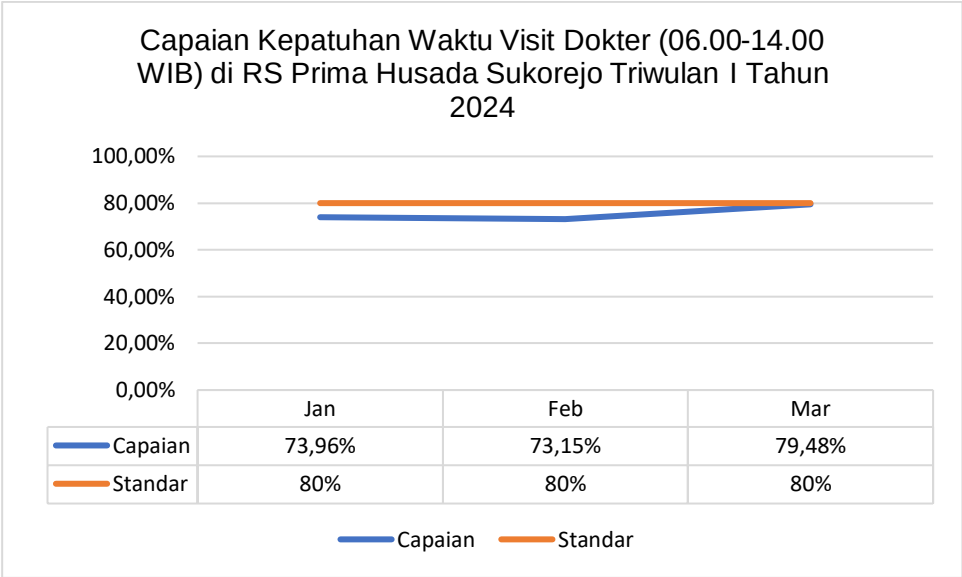
Problem	Rata-rata capaian waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit Triwulan I Tahun 2024 adalah 54,92%, belum mencapai target 80%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk waktu tunggu rawat jalan pasien
Plan	Rencana : Menurunkan angka capaian waktu tunggu rawat jalan pasien Harapan : Semua pasien mendapatkan pelayanan dokter kurang dari 60 menit Tindakan : a. Koordinasi dengan kepala ruang rawat jalan dan kepala bidang pelayanan terkait waktu tunggu rawat jalan pasien b. Koordinasi dengan CSO, Pendaftaran terkait pendaftaran yang bisa diakses melalui mobile jkn
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Waktu pasien rawat jalan yang didaftarkan di tempat pendaftaran sampai dilakukan oleh pemeriksaan oleh dokter
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian triwulan I yakni 54,92%, dapat disimpulkan bahwa waktu tunggu rawat jalan pasien yang kurang dari 60 menit belum mencapai target $\geq 80\%$. Dari 110 pasien yang diobservasi ditemukan 49 pasien yang menunggu lebih dari 60 menit dengan rata-rata 102 menit (1 jam 42 menit). Ini dikarenakan: a. Adanya pasien yang daftar awal sebelum jadwal praktek poli b. Adanya pendaftaran melalui Mobile JKN yang menyebabkan pasien yang daftar secara langsung ke Rumah Sakit yang menyebabkan nomor antriannya mundur. c. Adanya dokter poli yang melakukan kegiatan operasi ketika ada jadwal poli sehingga menimbulkan waktu tunggu yang lama di poli
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian triwulan I yakni 54,92%, dapat disimpulkan bahwa waktu tunggu rawat jalan pasien yang kurang dari 60 menit belum mencapai target $\geq 80\%$. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Koordinasi dengan kepala ruang rawat jalan dan kepala bidang pelayanan terkait waktu tunggu rawat jalan pasien 2. Koordinasi dengan CSO dan Pendaftaran terkait pendaftaran yang bisa diakses melalui mobile jkn yang bias diakses dimana pun. 3. Mengatur waktu DPJP antara jam Poly, Jam Visite Instalasi Rawat Inap, Jadwal Operasi adakah yang beririsan 4. Menggunakan kartu untuk mengukur pasien masuk dalam SIM (saat keluarnya SEP) dengan pemanggilan ke Poly (menggunakan sampel) 5. Monitoring dan evaluasi khusus progress tiap minggu



Tabel 3.8 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan kepala ruang rawat jalan dan kepala bidang pelayanan terkait waktu tunggu rawat jalan pasien	Menurunkan angka capaian waktu tunggu rawat jalan pasien	Seluruh pasien dapat mendapat perawatan dari dokter poli kurang dari 60 menit	Rapat koordinasi dengan kepala Bidang Pelayanan, Kepala Ruang Pendaftaran	Komite PMKP, Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Ruang Pendaftaran	Satu bulan
2	Koordinasi dengan CSO dan Pendaftaran terkait pendaftaran yang bisa diakses melalui mobile jkn yang bias diakses dimana pun.	Menurunkan angka capaian waktu tunggu rawat jalan pasien	Seluruh pasien dapat mendapat perawatan dari dokter poli kurang dari 60 menit	Rapat koordinasi dengan CSO dan kepala Kepala Ruang Pendaftaran	Komite PMKP, CSO, Kepala Ruang Pendaftaran	Satu bulan
3	Mengatur waktu DPJP antara jam Poly, Jam Visite Instalasi Rawat Inap, Jadwal Operasi adakah yang beririsan	Menurunkan angka capaian waktu tunggu rawat jalan pasien	Seluruh pasien dapat mendapat perawatan dari dokter poli kurang dari 60 menit	Rapat Koordinasi dengan Sekretaris Komite Medik, Kepala Bidang Pelayanan terkait jadwal dokter	Sekretaris Komite Medik, Kepala Bidang Pelayanan,	Satu bulan
4	Menggunakan kartu untuk mengukur pasien masuk dalam SIM (saat keluarnya SEP) dengan pemanggilan ke Poly (menggunakan sampel)	Waktu Tunggu Rawat Jalan diperoleh hasil yang akurat	Seluruh pasien dapat mendapat perawatan dari dokter poli kurang dari 60 menit	Sosialisasi pemakaian Kartu Formulir Pengumpulan Data dengan petugas pendaftaran dan asisten dokter	Komite Mutu	Satu bulan
5	Monitoring dan evaluasi terkait waktu tunggu rawat jalan pasien	Menurunkan angka capaian waktu tunggu rawat jalan pasien	Seluruh pasien dapat mendapat perawatan dari dokter poli kurang dari 60 menit	Supervisi yang dilakukan oleh Komite Mutu	Komite Mutu	Satu bulan

3. Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)



Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepatuhan waktu visite dokter spesialis kepada pasien rawat inap Triwulan I 2024 mencapai 75,53%. Capaian tersebut belum mencapai standar $\geq 80\%$. Ini diakibatkan karena dari 804 pasien rawat inap yang di observasi ditemukan 153 pasien yang di visite oleh dokter lebih dari jam 14.00 dan sebanyak 12 pasien yang tidak di visite oleh dokter.

Tabel 3.9 PDSA Capaian Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB) pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian waktu visite dokter pada Bulan Maret Tahun 2024 adalah 75,53%, belum mencapai target $\geq 80\%$
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk waktu visite dokter
Plan	Rencana : Meningkatkan capaian waktu visite dokter kepada pasien rawat inap Harapan : Semua pasien rawat inap dapat tervisite oleh dokter Tindakan : a. Koordinasi dengan kabid pelayanan dan komite medik b. Pemaparan jumlah dokter yang tidak visite dengan tepat waktu
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. kesesuaian waktu visite dokter kepada pasien
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian triwulan I yakni 75,53% dapat disimpulkan bahwa waktu visite dokter spesialis belum mencapai $\geq 80\%$. Ini diakibatkan karena dari 804 pasien rawat inap yang di observasi ditemukan 153 pasien yang di visite oleh dokter lebih dari jam 14.00 dan 12 pasien yang tidak di visite oleh dokter. Ini dikarenakan: a. Rata-rata dokter visite yang lebih dari 14.00 WIB memiliki jadwal praktek di Rumah Sakit lain sehingga jadwal di RS Prima Husada Sukorejo lebih dari jam 14.00 WIB b. Adapun nama-nama dokter yang tidak melakukan visit ke pasien adalah sebagai berikut: 1) dr. Rudi Priyo Utomo, Sp.OG (5 kali)-----RSSA 2) dr. Aan Dwi Prasetyo, Sp.N (1 kali) 3) dr. Dio Mafazi, SP.U (1 kali) 4) dr. Zaki Yamani, Sp.B (1 kali) 5) dr. Fauzia Risma Rahayu, Sp.N (1 kali) 6) dr. Ratih Kusumawardani, Sp.A., M.Biomed (1 kali) 7) dr. Maria Valentina Evelyn, Sp. JP (1 kali) 8) dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp.N (1 kali)

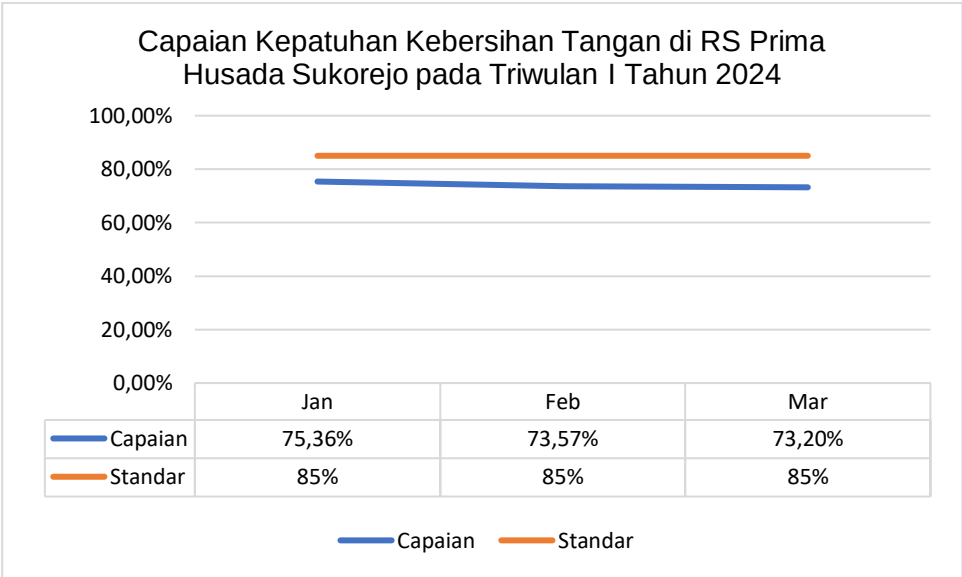


Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian triwulan I yakni 75,53% dapat disimpulkan bahwa waktu visite dokter spesialis belum mencapai $\geq 80\%$. Ini diakibatkan karena dari 804 pasien rawat inap yang di observasi ditemukan 153 pasien yang di visite oleh dokter lebih dari jam 14.00 dan 12 pasien yang tidak di visite oleh dokter. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Koordinasi dengan kepala bidang pelayanan dan komite medik untuk melakukan peneguran pada dokter yang tidak visit dan tidak konfirmasi ke dokter jaga. 2. Mengatur waktu DPJP antara jam Poly, Jam Visite Irna, jam Operasi adakah yg beririsan termasuk dengan jam praktek DPJP di RS lain. 3. Merekrut Home doctor
--------	--

Tabel 3.10. Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan kepala bidang pelayanan dan komite medik untuk mengingatkan visit ke pasien	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Dokter yang tidak visit ke pasien	Rapat koordinasi dengan komite medik	komite medik	Satu bulan
2	Mengatur waktu DPJP antara jam Poly, Jam Visite Irna, jam Operasi adakah yang beririsan termasuk dengan jam praktek DPJP di RS lain.	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Dokter yang tidak visit ke pasien	Rapat koordinasi dengan Dokter, Sekretaris Komite Medik, Kabid Pelayanan	Sekretaris Komite Medik, Kabid Pelayanan	Satu bulan
3	Merekrut Home Dokter	Semua pasien rawat inap dapat tervisite	Home Dokter	Koordinasi dengan SDM terkait dokter yang tidak bisa visit	SDM	Satu bulan

4. Kepatuhan Kebersihan Tangan Petugas



Tabel 3.11 Analisis Capaian Indikator Nasional yang Tidak Di Inginkan pada Triwulan I Tahun 2024

Standar	Judul Indikator	Standar	Capaian Bulan			Rata-rata	Area
			Jan	Feb	Mar		
Nasional	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥85%	75,36 %	73,57%	73,20%	74,04 %	All rawat inap, rawat jalan, farmasi, IGD, Kamar operasi, Laboratorium , radiologi, gizi & dapur

Hasil Capaian :

Berdasarkan capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada Triwulan I belum mencapai ≥85%, yaitu 74,04%. Dari 14 unit yang di observasi Masih ditemukan 12 unit yang capaiannya < 85% yakni IRNA 3A 41%, IRNA 3B 80%, IRNA 2A 74%, IRNA 2B 77%, ICU 63%, Maternitas 77%, Neonatologi 79%, IGD 83%, IKO 43%, IRJA 60%, Farmasi 73%, Radiologi 68%.

Tabel 3.12 PDSA Capaian Kepatuhan kepatuhan kebersihan tangan petugas pada Triwulan I Tahun 2024

Problem	Persentase kepatuhan kebersihan tangan pada Triwulan I kurang dari 85% yakni 74,04%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan kebersihan tangan secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf pelayanan medik melakukan kebersihan tangan dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan - Melakukan audit kebersihan tangan pada staf pelayanan medik di unit secara berkesinambungan. - Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kebersihan tangan - Koordinasi dengan PJ PPI di unit untuk meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan staf di unit.



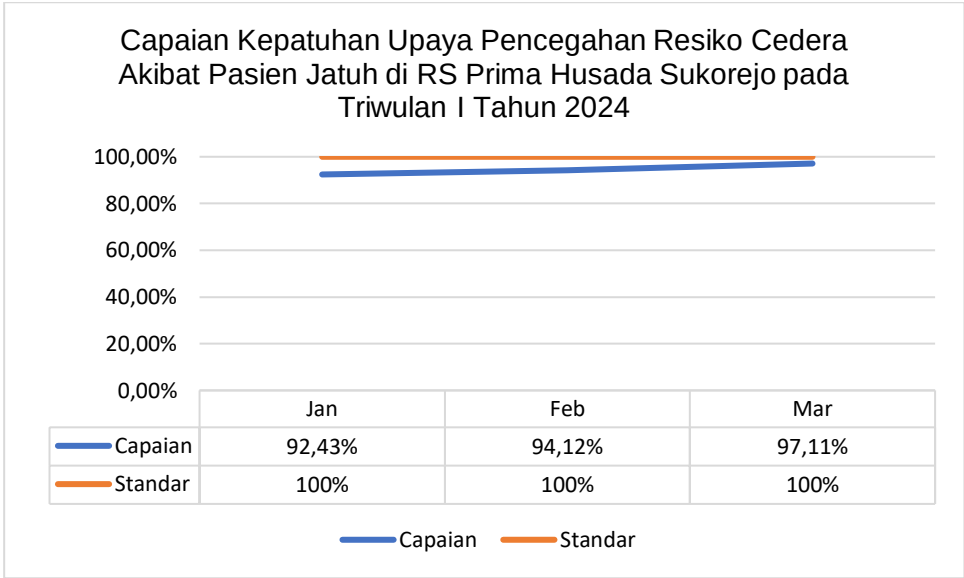
Do	Kepatuhan kebersihan tangan dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen sesuai 5 momen yaitu: 1. Sebelum kontak dengan pasien 2. Sebelum tindakan aseptik 3. Setelah terkena cairan tubuh pasien 4. Setelah kontak dengan pasien 5. Setelah kontak dengan lingkungan di sekitar pasien
Study	1. Rata-rata capaian kepatuhan kebersihan tangan triwulan I mencapai 74,04% yang belum mencapai standar 85 %. Ini disebabkan dari 3616 petugas yang melakukan kebersihan tangan selama 1 bulan, 2647 petugas yang patuh dan mempraktekan teknik 6 langkah dan 5 momen yang sesuai. 2. Fasilitas kebersihan tangan bulan Maret 2024 sudah 100% terpenuhi 3. Ditemukannya petugas yang tidak melakukan kebersihan tangan sebelum menggunakan handscoon. Beberapa titik wastafel ditemukan tidak ada handwash dan handtowel.
Action	1. Review dan evaluasi pelaksanaan pelatihan PPI dasar 2. Kolaborasi antara Komite PPI dan kbid keperawatan terkait monitoring kepatuhan kebersihan tangan 3. Jika ditemukan petugas yang tidak dapat mempraktikkan kebersihan tangan dengan benar, beri tugas untuk melakukan edukasi kelompok dan dikumpulkan berupa video. 4. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. 5. Berikan feedback hasil audit dan monitoring 6. Pemberian proses pembelajaran

Tabel 3.13 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Rencanakan pelatihan kebersihan tangan untuk staf baru yang sudah melewati masa training 3 bulan.	Meningkatkan skill petugas baru dalam melakukan kebersihan tangan	Skill petugas dalam melaksanakan cuci tangan sesuai dengan SPO	Pelatihan kebersihan tangan kepada staff baru	Komite PPI	Satu bulan
2	Koordinasi antara Komite PPI, Kabid Keperawatan dan SDM terkait petugas yang tidak patuh dalam upaya kebersihan tangan	Menjalin koordinasi secara berkesinambungan	Semua petugas terutama petugas medis	Rapat rutin antara Komite PPI, Kabid Keperawatan dan SDM	Komite PPI, Kabid Keperawatan dan SDM	Satu bulan
3	Lakukan monitoring	Memastikan bahwa kepatuhan	All petugas melaksanakan	Monitoring dan evaluasi	Komite PPI	Satu bulan

	evaluasi kepatuhan di setiap briefing.	kebersihan tangan sudah dilakukan	n kebersihan tangan sesuai moment dan langkahnya	berkala		
--	--	-----------------------------------	--	---------	--	--

5. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh



Tabel 3.14 Analisis Capaian Indikator Nasional yang Tidak Ditinginkan pada Triwulan I Tahun 2024

Standar	Judul Indikator	Standar	Capaian Bulan			Rata-rata	Area
			Jan	Feb	Mar		
Nasional	Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh	100%	92,43 %	94,12%	97,11%	94,55%	All rawat inap, rawat jalan

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada Triwulan I Tahun 2024 adalah 85,78%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Dari 1282 pasien yang di observasi ditemukan 29 petugas yang tidak patuh dalam melakukan skrinning awal dan 8 petugas yang tidak patuh dalam skrinning ulang.

Tabel 3.15 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Triwulan I Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Triwulan I Tahun 2024 adalah 94,55%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan risiko jatuh
Plan	Rencana : Meningkatkan pengetahuan petugas mengenai pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh Harapan : Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien cedera akibat pasie jatuh dapat tercapai 100% Tindakan : a. Koordinasi dengan Kepala Ruang, Kepala Bidang Keperawatan dan SDM terkait nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya



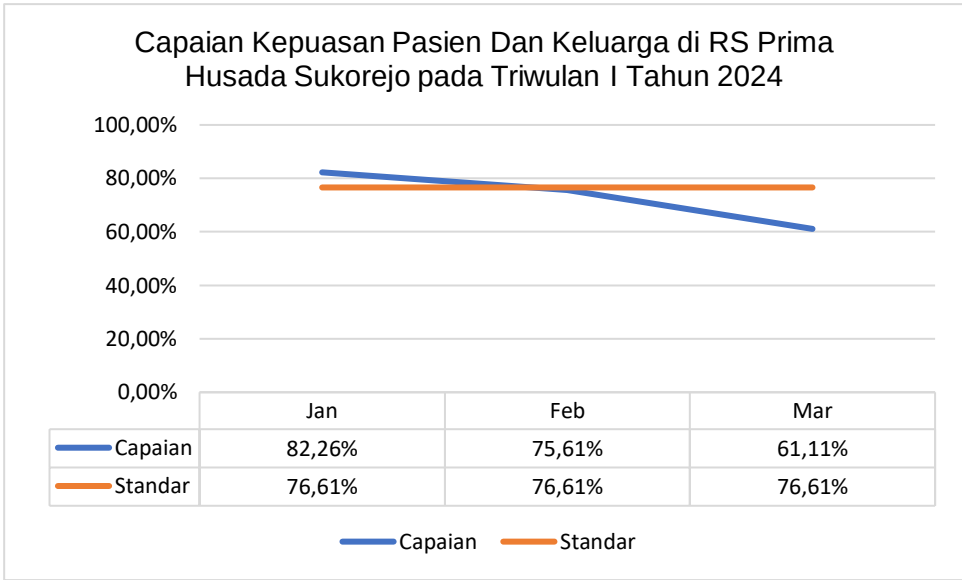
	pengegasan resiko jatuh b. Monitoring dan Evaluasi terkait nama staff yang tidak patuh dalam upaya pengegasan resiko jatuh
Do	Apa pengamatan yang dilakukan? 1. Melihat kepatuhan petugas dalam skrinning awal pasien jatuh di pintu masuk 2. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi asesmen awal pasien 3. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi asesmen ulang pasien indikasi resiko jatuh 4. Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian kepatuhan upaya pengegasan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Triwulan I Tahun 2024 adalah 94,55%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan masih ditemukan petugas yang tidak patuh dalam melakukan skrinning awal dan ulang maupun intervensi pada pasien yang berisiko jatuh. Adapun nama-nama yang tidak patuh dalam upaya pengegasan risiko cedera akibat pasien jatuh antara lain: 1. Indah Wulan Suci, A.Md.Kep 2. Dimas Ragil Anarkie, A.Md.Kep 3. Selly Mercelia Prasisti, Amd. Kep 4. Vira Agustin Sintia Putri, A.Md.Kep 5. Rezza Anggela Santoso., S.Kep.Ns. 6. Istighosah, A.Md.Kep 7. Firdhausi Nuzula., Amd Kep 8. Ana Nurul Firdausi, A.Md.Kep
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? rata-rata capaian kepatuhan upaya pengegasan risiko akibat pasien jatuh pada bulan Triwulan I tahun 2024 adalah 94.55%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Dari 1282 pasien yang di observasi ditemukan 29 petugas yang tidak patuh dalam melakukan asesmen awal dan 8 petugas yang tidak patuh dalam asesmen ulang. Follow-up dan Rencana Lanjutan a. Koordinasi dengan Kepala Ruang, Kepala Bidang Keperawatan dan SDM terkait nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya pengegasan resiko jatuh b. Monitoring dan Evaluasi terkait nama staff yang tidak patuh dalam upaya pengegasan resiko jatuh

Tabel 3.16 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan Kepala Ruang, Kepala Bidang Keperawatan dan SDM terkait nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya pengegasan resiko jatuh	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam Upaya pengegasan risiko cedera akibat pasien jatuh	Nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya pengegasan risiko akibat pasien jatuh	Koordinasi dengan kepala ruang Unit, Kepala Bidang Keperawatan, SDM	kepala ruang Unit, Kepala Bidang Keperawatan, SDM	Satu Bulan
2	Monitoring	Meningkatkan	Nama-nama	Monitoring	Kepala	Satu

	dan Evaluasi terkait nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh	kepatuhan petugas dalam Upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh	staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh	dan evaluasi berkala	Ruangan, Komite Mutu	Bulan
--	--	--	--	----------------------	----------------------	-------

6. Kepuasan Pasien dan Keluarga



Tabel 3.17 Analisis Capaian Indikator Nasional yang Tidak Dinginkan pada Triwulan I Tahun 2024

Standar	Judul Indikator	Standar	Capaian Bulan			Rata-rata	Area
			Jan	Feb	Mar		
Nasional	Kepuasan pasien dan keluarga	≥76,61%	82,26 %	75,61%	61,11%	72,99%	IGD, All rawat inap, rawat jalan, farmasi, radiologi, laboratorium , humas & marketing, MOD

Hasil Capaian:

Pada grafik tersebut diketahui bahwa Kepuasan Pasien dan Keluarga pada Triwulan I Tahun 2024 adalah 72,99. Angka tersebut belum mencapai target 76,61%. Dari 18 pasien yang menyecan barcode survey kepuasan pasien, 7 pasien menyatakan ketidakpuasan dengan pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dan 11 pasien yang lain menyatakan puas dengan pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

Tabel 3.18 PDSA Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian kepuasan pasien dan keluarga pada Triwulan I yaitu 72,99%, angka tersebut tidak mencapai standar 76,61%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit untuk meminta pasien atau keluarga pasien menyecan barcode survey kepuasan pasien setelah terlayani di masing-masing unit
Plan	1. Rencana: Meningkatkan capaian kepuasan pasien dan keluarga di RS Prima Husada Sukorejo 2. Harapan Pasien dan keluarga pasien merasa puas dengan pelayanan di RS Prima

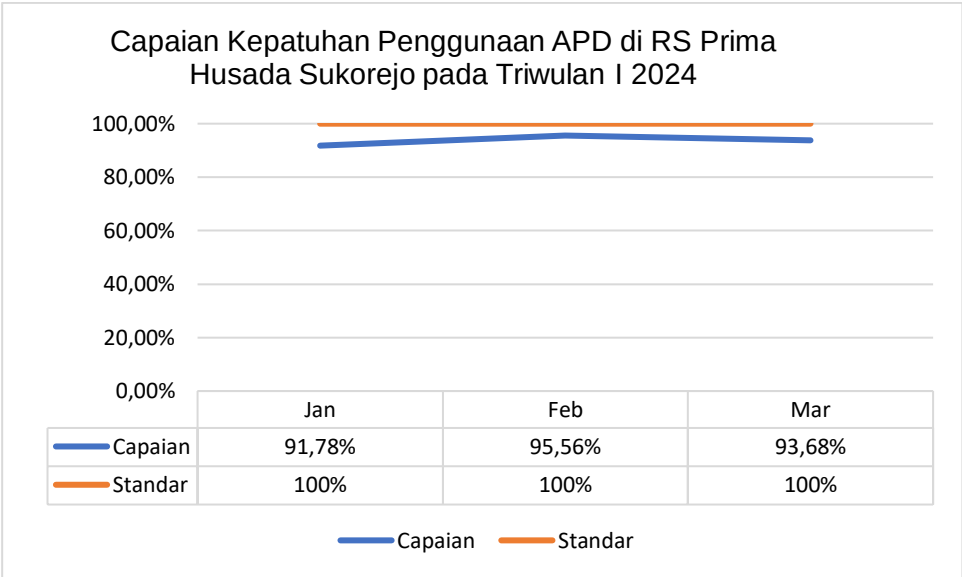


	Husada Sukorejo 3. Tindakan a. Berkoordinasi dengan Kepala Ruangan Unit agar mengarahkan pasien menyecan barcode kepuasan setelah dilayani di masing-masing unit b. Berkoordinasi dengan kbid penunjang terkait pelayanan petugas farmasi c. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap hasil survey kepuasan pasien
Do	Pasien dapat menyecan barcode survey kepuasan pasien dan keluarga sehingga dapat menilai pelayanan dari Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
Study	Berdasarkan capaian kepuasan pasien dan keluarga pada Triwulan I tahun 2024 adalah 72,99%. Angka tersebut belum mencapai target 76,61%. Dari 18 pasien yang menyecan barcode survey kepuasan pasien, 7 pasien menyatakan ketidakpuasan dengan pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo. Adapun ketidakpuasan pasien adalah sebagai berikut: 1. Pelayanan Petugas dengan attitude yang kurang ramah 2. Waktu tunggu pelayanan obat yang lama
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian kepuasan pasien dan keluarga pada Triwulan I tahun 2024 adalah 72,99%. Angka tersebut belum mencapai target 76,61%. Dari 18 pasien yang menyecan barcode survey kepuasan pasien, 7 pasien menyatakan ketidakpuasan dengan pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo. Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Berkoordinasi dengan kepala ruangan agar mengarahkan pasien menyecan barcode kepuasan setelah dilayani di masing-masing unit 2. Berkoordinasi dengan kbid penunjang terkait pelayanan petugas farmasi 3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap hasil survey kepuasan pasien

Tabel 3.19 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan kepala ruangan agar mengarahkan pasien menyecan barcode kepuasan setelah dilayani di masing-masing unit	Survey kepuasan pasien dan keluarga dapat berjalan optimal	Seluruh pasien dan keluarga yang mendapatkan pelayanan di RS Prima Husada Sukorejo	Koordinasi dengan Kepala Ruangan di Unit masing-masing	Komite Mutu dan semua Kepala ruang unit	Satu bulan
2	Berkoordinasi dengan kbid penunjang, dan kepala ruang farmasi terkait pelayanan petugas farmasi dalam pemberian obat	Kepuasan pasien dan keluarga dapat optimal	Seluruh petugas farmasi	Koordinasi dengan Kbid Penunjang, Kepala Ruang Farmasi	Kbid Penunjang, Kepala Ruang Farmasi	Satu bulan

7. Kepatuhan Penggunaan APD



Tabel 3.20 Analisis Capaian Indikator Nasional yang Tidak Di Inginkan pada Triwulan I Tahun 2024

Standar	Judul Indikator	Standar	Capaian Bulan			Rata-rata	Area
			Jan	Feb	Mar		
Nasional	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	91,78 %	95,56%	93,68%	93,67%	All rawat inap, rawat jalan

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan penggunaan APD pada Triwulan I adalah 93,67%. Dari 18unit yang di observasi masih ditemukan 8 unit yang angka capaiannya belum 100% yakni IRNA 3A 90%, IRNA 3B 97%, IRNA 2A 97%, IRNA 2B 97%, IKO 87%, Laboratorium 53%, Gizi & Dapur 83%, dan CS 83%.

Tabel 3.21 PDSA Capaian Kepatuhan penggunaan APD pada Triwulan I Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian kepatuhan penggunaan APD pada Triwulan I yaitu 93,67%, angka tersebut tidak mencapai standar 100%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya penggunaan APD untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD oleh petugas di RS Prima Husada Sukorejo 2. Harapan: Seluruh staf pelayanan patuh dalam penggunaan APD sehingga target kepatuhan dapat dicapai 3. Tindakan: a) Melakukan audit penggunaan APD pada staf pelayanan medik di unit secara berkesinambungan. b) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penggunaan APD c) Koordinasi dengan Komite PPI untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan APD staf di unit.
Do	Kepatuhan penggunaan APD meningkat hingga mencapai 100% di bulan berikutnya.
Study	1. Masih ditemukan petugas yang tidak tepat dalam penggunaan masker dan



	handscoon sesuai indikasi (IRNA). 2. Petugas tidak menggunakan APD yang tepat di area dapur.
Action	1. Review dan evaluasi hasil pelatihan penggunaan APD pada staf. 2. Beri feedback pada hasil temuan. 3. Kolaborasi dengan komite keperawatan untuk monitoring penggunaan APD di unit. 4. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. 5. Beri teguran saat melakukan monitoring penggunaan APD yang tidak sesuai indikasi di unit.



Tabel 3.22 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Review dan evaluasi hasil pelatihan penggunaan APD pada staf.	Staf dapat melaksanakan penggunaan dan melepaskan APD sesuai langkah dengan indikasinya	Seluruh staf rawat inap dapat melaksanakan penggunaan APD dan pelepasan APD 100% benar	Resosialisasi	Komite PPI	Satu bulan
2	Beri feedback pada hasil temuan.	Ruangan dapat mengetahui apa yang harus diperbaiki	All ruangan yang di audit	Pemberian feedback	Komite PPI	Satu bulan
3	Kolaborasi dengan komite keperawatan untuk review kebutuhan penggunaan APD	Menjalin koordinasi secara kesinambungan antar komite	Komite keperawatan dapat ikut serta dalam pemantauan kebersihan utamanya perawat	Rapat dengan komite keperawatan	Komite PPI dan komite keperawatan	Satu bulan
4	Melakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja.	Memastikan bahwa kepatuhan APD tangan sudah dilakukan	Seluruh staf rawat inap dapat melaksanakan penggunaan APD dan pelepasan APD 100% benar	Supervisi petugas yang tidak tepat dalam penggunaan APD	Komite PPI dan SDM	Satu bulan
5	Lakukan monitoring evaluasi kepatuhan di setiap briefing.	Memastikan bahwa kepatuhan APD tangan sudah dilakukan	All petugas melaksanakan penggunaan APD tangan sesuai moment dan langkahnya	Monitoring dan evaluasi	Komite PPI	Satu bulan

Direktur RS Prima Husada Sukorejo,



dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS.